

Fecha Última Actualización: 23-03-2022 13:33:12

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Nelia Miguelina Llaituqueo Naipil
Edad : 71a 4m 21d
Dirección : Azulillo, 2003 V.Primavera

Rut : 6.757.618-7
Fecha Nacto: 02/11/1950
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1127842
Sexo : Femenino
Teléfono : 945329706

N° Epicrisis
294881

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Emergencia Adulto

Fecha Ingreso : 31/01/2022 14:31

Días Estadía: 51

Unidad de Egreso : Medicina Básica (2do Piso)

Fecha Egreso : 23/03/2022 15:00

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Neumonía COVID grave

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EVOLUCIÓN EN UCI- UTIM- Sala

- Hemodinámico: Con requerimientos a dosis bajas de NAD en contexto de sedación. Luego con tendencia a la hipertensión, se ajusta anti HTA orales con lo que presiones evolucionan a la mejoría. Edematosa se maneja con diuréticos para BH negativos. Se traslada a UTIM, evoluciona estable con requerimientos de dosis bajas NAD hasta el 23/02. Luego con tendencia a hipertensión por lo que se ajustan DVO orales con buen control PA. No es conflicto al momento del alta a UDH.

- Cardiovascular: paciente ingresa a sala con req de O2 que evolucionan estacionarios, impresiona en contexto de ICC descompensada, respondiendo a manejo depletivo. Dado antecedentes médicos de ICC con ecocardiograma extrasistema 21/10/21 con FE de 30 %, aurícula izquierda severamente dilatada, HTP y arritmia actual se decide realizar IC a equipo de cardiología y nuevo ecocardiografía formal que se realiza el 07/03 que muestra FE: 33%, aurícula izquierda no dilatada, sin HTP, hypokinesia de pared anterolateral y apical. Se realiza Coronariografía el 14/03 que muestra ausencia de stents, ramas permeables e imagen radiolúcida en DP que podría corresponder a un trombo. En ECG 16/03 se constata FA por lo que se inicia anticoagulación con enoxaparina dado buena función renal. Evaluada nuevamente por cardiología con nuevos hallazgos quienes indican que etiología más probable de hipokinesia miocárdica se deba a antecedente de IAM, sin embargo no se cuenta con mayor información de este episodio ya que fue extrasistema. Además sugieren anticoagulación dado FA vs taquicardia auricular, pendiente traslape a TACO en UDH. En globo se considera que la paciente no requiere estudio imagenológico adicional y que lo fundamental es mantener una terapia farmacológica óptima como manejo de su ICC. Queda en control con cardiología de manera ambulatoria. Se conversa con cardiología quien realiza sobrecupo para el 06/04/22 a las 12:00 hrs en CDT pasillo 8

- Ventilatorio: Paciente ingresa en insuficiencia respiratoria aguda que requiere IOT. Se inicia ventilación protectora. Requiere bloqueo neuromuscular y prono 2 ciclos (01-06/02 y luego 07-12/02) desde ahí mantiene PAFI 200, se logra extubar 20/02 a las 15:00 horas con apoyo de VMNI. Con weaning consolidado se traslada a UTIM para continuar manejo y rehabilitación donde continúa requerimiento de BIPAP por miopatía severa de paciente crítico + obesidad. Desde 25/02 sin necesidad de VMNI. El 28/02 destete de oxígeno, a FiO2 ambiental con SpO2 adecuada. Al traslado a sala con manejo con BD + KNTR, logra destete de O2 el 17/03, actualmente en rehabilitación con kine respiratoria, evolución favorable.

- Infeccioso: Ingres a al hospital por NAC grave por Covid 19 (PCR SARS CoV2 no realizada por antecedente de contacto estrecho), en su día + 8 de síntomas. Recibe Dexametasona 6 mg al día por 10 días, finaliza el 09/02/22. En contexto de parámetros inflamatorios elevados asociado a condensaciones bi basales al TAC de tórax se inició Ampicilina/Sulbactam, que

Fecha Epicrisis : 23/03/2022 13:33

Página 1 de 4

Fecha Última Actualización: 23-03-2022 13:33:12

Página 2 de 4

se mantuvo por cultivo con SAMS, luego nuevamente con broncorrea, se cultiva y se aísla PSAE que se maneja con Ceftazidima por 10 días. Se traslada a UTIM donde se completa tratamiento con Ceftazidima el 25/02. Evoluciona en UTIM con peak febril hasta 37.6° con SO inflamatorio, UC polimicrobiano y HC I/II (-). Debido a esto se decide completar tratamiento con amikacina (terminó:01/03). Exámenes de control con parámetros inflamatorios a la baja (PCR: 5.4, GB:8.3), sin síntomas urinarios luego de completar terapia antibiótica. Control de parámetros inflamatorios a la baja (21/03 PCR 3.8), se mantiene en sala afebril sin nuevos quiebres clínicos.

- Renal: en sala presenta hipokalemia en múltiples oportunidades y necesidad de aporte de K vía oral, impresiona en contexto de manejo depleitivo con furosemda. El 08/03 se suspende aporte vía oral en contexto de K en 4.5. Control de ELP el 09/03 K en 3.88, en contexto de falla renal con alza de crea hasta 0.89 se mantienen manejo expectante con control de ELP. Se mantiene con exámenes semanales para evaluar medio interno y nutrición. Últimos exámenes 21/03/22 Prealbúmina 19.1 Ca 8.9 P 4.5 Mg 2.0 ELP 138/5.1/104.

Con respecto a falla renal con alza de crea del 09/03 hasta 0.89 y BUN hasta 40, asociado a oliguria (post retiro de S. foley), impresiona de componente mixto, con pre renalidad por uso de diuréticos y post renalidad por retención urinaria post retiro de foley. Con ajuste de terapia diurética y foley a mantención presenta franca mejoría de diuresis y BUN/crea- último control de función renal de 21/03 presenta parámetros normales, con crea 0.58 BUN 10.8.

Urológico: se solicita evaluación a urología por retención urinaria y sospecha de falla renal de causa post renal. A la evaluación por la especialidad definen que probablemente se deba a vejiga neurogénica en contexto de recuperación de COVID grave. De momento, se sugiere mantener sonda foley y una vez resolución de cuadro actual y paciente encontrarse en mejores condiciones considerar retirar la sonda foley y realizar prueba miccional midiendo RPM por sondeo. Se da de alta a UHD con sonda foley, pendiente acudir a control ambulatorio con urología para definir manejo.

Neurológico: ingresa a sala con delirium hipoactivo probablemente asociado a episodio de infección urinaria, por lo que se desestima necesidad de estudio posterior. Se maneja con medidas generales anti delirium con buena respuesta clínica. Sin nuevos episodios de delirium desde el día 14/03/22, manteniéndose orientada en tiempo y espacio. Sin episodios de desorientación posteriores, sin otros conflictos.

Rehabilitación:

Motor/Deglución: cursa con trastorno de deglución en contexto de VM con IOT que resuelve durante su estadía en sala. FNA autoriza inicio de régimen licuado el 25/02. Al momento del alta con régimen blando sin granos, líquidos claros, vigil y sentada a 90° sin conflicto. Además cursando miopatía de paciente crítico inicialmente con evidente disminución de fuerza a nivel proximal y distal que se mantiene en rehabilitación por parte del equipo de kinesiología. Previo al alta logra alimentación independiente y logra control de tronco sin embargo aún no logra sedestación o bipedestación.

Nutricional: paciente con desnutrición severa por criterios GLIM. Con regular adherencia a régimen que mejora posterior a contención emocional logrando aumentar intake calórico diario. Últimos exámenes de laboratorio nutricionales descritos previamente.

DIAGNÓSTICOS AL ALTA:

ICC FE reducida en tratamiento

Anticoagulación por FA

Miopatía del paciente crítico en rehabilitación

Insuficiencia respiratoria aguda resuelta

- SDRA 2rio Neumonía COVID grave con req de VMI resuelta

- NAVM tratadas: PSAE (R Carba) y SAMS.

Portadora de KPN NDM, E. coli y P. mirabilis.

Antecedentes: HTA, ICC FE r (30%), Cáncer renal operado, obesidad.

Interno Barnafi /Dra. González /Dra. Olivares

Residencia Medicina Interna

Diagnóstico de Egreso

Fibrilación Auricular De Reciente Inicio - Anticoagulada

Insuficiencia Respiratoria Aguda Parcial - Resuelta

Obesidad (Imc) - Asociado A Miopatía De Paciente Crítico

Insuficiencia Cardíaca Global - Fe: 33%, Aurícula Izquierda No Dilatada, Sin Htp, Hypokinesia De Pared Anterolateral Y Apical.

Fecha Epicrisis : 23/03/2022 13:33

Página 2 de 4

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J: NO

CONDICIÓN DE ALTA

Paciente en buenas condiciones generales, hemodinámicamente estable, afebril, sin dolor, síntomas respiratorios/gastrouritarios. Sin requerimientos de oxígeno. Buena tolerancia oral, sin náuseas o vómitos. Diuresis y deposiciones conservadas.

Actualmente logra alimentarse sola y sedestación asistida.

EXÁMENES DE LABORATORIO RECIENTES

21/03/22: Alb 2.8 Prealbúmina 19.1 Ca 8.9 P 4.5 Mg 2.0 Crea 0.58 BUN 10.8 Gluc 85 PCR 3.8 ELP 138/5.1/104

16/03: Ca 8.3 Crea 0.56 BUN 24.1 P 3.5 ELP 134/4.1/103

15/03: Prealbúmina 12.2 ELP 132/3.52/100

14/03: Albumina 2.7 Ca 8.3 P 3.9 Crea 0.68 BUN 27 Mg 1.6 ELP 132/3.8/101

11/03:ELP: 136/3.59/103, Alb: 2.9, Ca:9.1, Crea:0.58, BUN: 23.4, GSV: ph:7.397, CO2:40.9, HCO3:24.6, EB: -0.2

10/03: Crea: 0.68, BUN: 30.2, P:3.4.Mg:1.8, PCR:3.9, Ca:9.3, Alb:3.2.

09/03: ELP:135/3.88/101, Crea:0.89, BUN: 30.5, TUS: < 10.

Microbiológico:

04/03: OC (-) y UC (polimicrobiano)

26/02: OCT inflamatoria, UC polimicrobiano

25/02: Cultivo por

Plan Post Alta

MEDIDAS GENERALES

Reposo relativo asistido.

Régimen blando, hiperproteico, hiposódico, fraccionado en 3 comidas y 3 colaciones. Comer sentada 90°, vigil y vigilado.

Continuar con rehabilitación en UHD : KTR + KTM

Invasivos: Sonda Foley, mantener control de diuresis

FÁRMACOS

Berodual 2 puff cada 8 h por aerocámara.

Losartan 50 mg cada 12 h vía oral

Carvedilol 12.5 mg AM + 6.25 mg PM vía oral.

Amlodipino 10 mg/cada 12 vía oral

Espironolactona 25 mg c/24h vía oral

Atorvastatina 40 mg/día vía oral

Aspirina 100 mg/día vía oral

Paracetamol 1 grs cada 8 hrs vía oral

Enoxaparina 100 mg SC cada 12 hrs (suspender luego de traslape TACO)

Tomar Acenocumarol 1 comprimido 4mg hoy (23/03) y 1 comprimido 4 mg (24/03), control INR 25/03 AM y ajustar terapia

Omeprazol 20 mg/día vía oral

Pregabalina 37.5 mg en la noche por 1 semana, luego 75 mg (1 comprimido) en la noche vía oral

PEG 17 g c/día VO

CONTROLES

Hospitalización domiciliaria: terapia kinésica respiratoria, motora y traslape a TACO

Hora con cardiología en CDT Pasillo 8 el día 06/04/22 a las 12:00 hrs. Acudir media hora antes.

Continuar controles habituales en consultorio.

Solicitar control con urología en CDT

URGENCIAS

Consultar en servicio de urgencias en caso de fiebre o dolor que no ceda con paracetamol, dificultad para respirar o sensación de ahogo, que la piel alrededor de la boca o de las manos se torne azul, dolor torácico opresivo intenso, o cualquier síntoma que estime conveniente sea evaluado por un médico en la urgencia.

Fecha Última Actualización: 23-03-2022 13:33:12

Página 4 de 4

Interno Barnafi /Dra. González /Dra. Olivares
Residencia Medicina Interna

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo Asistido

Régimen Alimentario : Blando, Hiperproteico, Hiposódico, Fraccionado En 3 Comidas Y 3 Colaciones. Comer Sentada 90°, Vigil Y Vigilado.

Medicamentos :

Controles

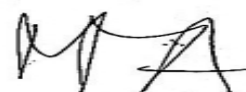
Esteban Andrés Barnafi Wittwer

INTERNO



Cecilia Ignacia Gonzalez Almonaci

Becado/Residente



Patricia Olivares Osorio

Médico Tratante (Staff)